

CANAL ATRIO-VENTRICULAIRE (CAV)

Pr. RABEARVONY Nirina
Cardiologue

PLAN

- Introduction
- CAV complet
- CAV partiel
- Conclusion

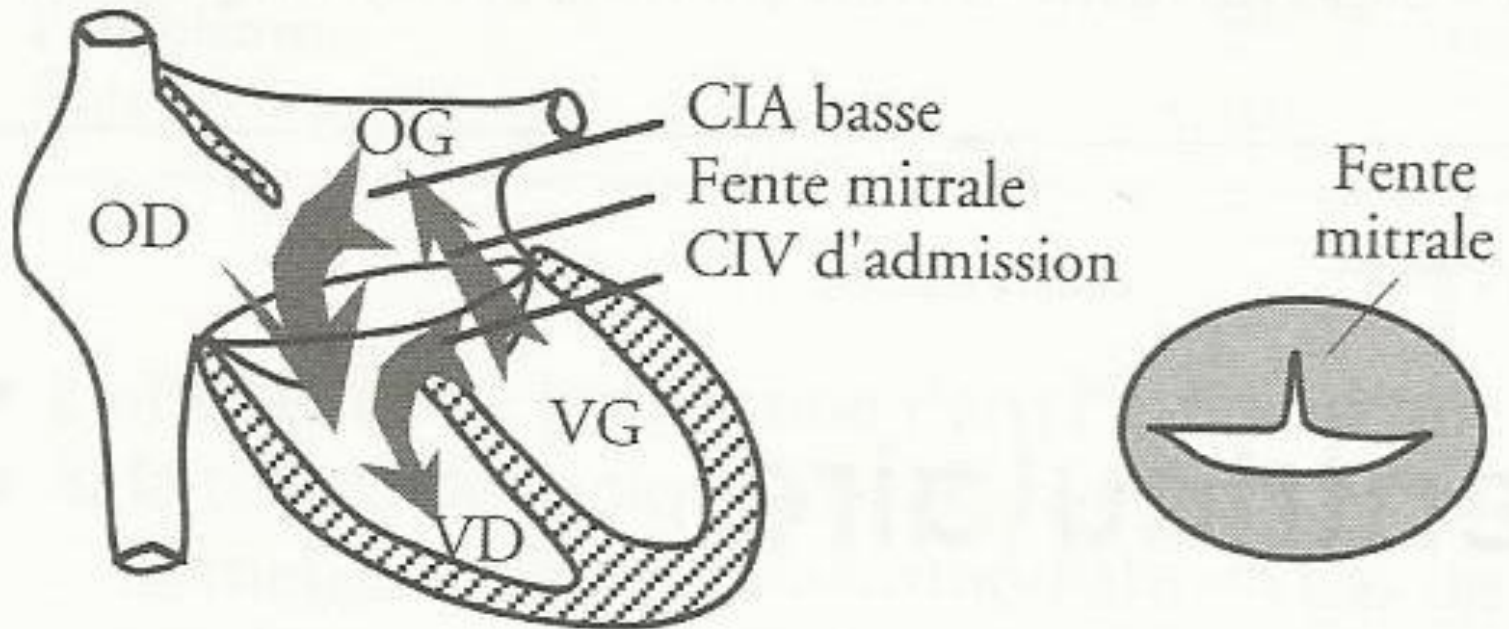
INTRODUCTION

- **Définition:**
 - **CAV partiel** = CIA ostium primum + fente mitrale
 - **CAV complet** = CIA ostium primum + fente mitrale + anneau AV commun + CIV haute
 - tous les intermédiaires sont possibles
 - 4 % des cardiopathies congénitales

CAV complet

- **Anatomo-pathologie:**
 - trisomie 21 ++++
 - association de:
 - CIA ostium primum large
 - une valve AV commune
 - une fente mitrale
 - CIV d'admission (haute)

CAV complet



CAV complet

- **Physiopathologie:**

- shunt CIV → surcharge pulm. + dilatation VG
- shunt CIA → dilatation OD, VD + surcharge pulm.
- shunt + HTAP → altération des artérioles pulm.
→ « HTAP fixée » dès l'âge de 6 mois
- fente mitrale → insuffisance mitrale (favorise le shunt CIA)

CAV complet

- **Diagnostic:**

- Clinique:

- SF : importants, proportionnels au shunt
début vers 15 ème jour de vie
(dyspnée, difficultés alimentation,
hypotrophie)

- SP: souffle de CIV, discret
éclat de B1 et B2
roulement mitral d'hyperdébit à l'apex

CAV complet

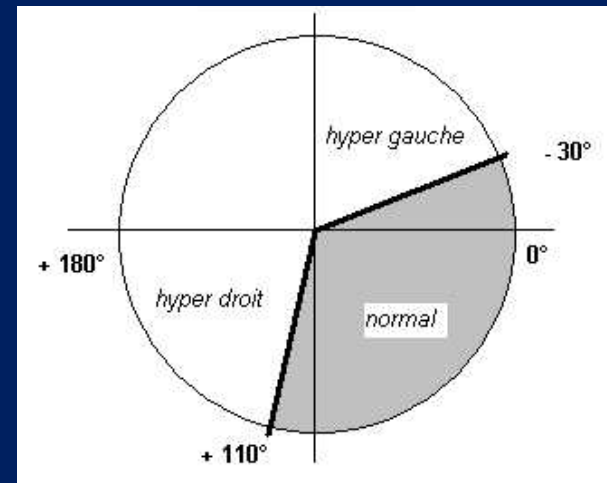
- **Diagnostic:**

- Radiographie:

- cardiomégalie
 - hypervascularisation pulm.

- ECG:

- **axe de QRS au plafond (- 60 °)**
 - HVD, HVG
 - BAV 1



CAV complet

- **Diagnostic:**
 - Echodoppler
 - affirme le diagnostic
 - évalue l'importance des shunts
 - évalue l'HTAP
 - apprécie l'importance de la fuite mitrale
 - recherche les anomalies associées (PCA, CIV multiples,

CAV complet

- **Evolution:**

- jusqu'à 6 mois:

- complications des shunts G-D → défaillance cardio-respiratoire

- après 6 mois:

- HTAP fixée → diminution des shunts
→ amélioration clinique

- à tout âge:

- endocardite d'Osler

CAV partiel

- **Anatomo-pathologie:**

- trisomie 21 (rarement)
- association de:
 - CIA ostium primum
 - fente mitrale

- **Physiopathologie:**

- shunt CIA → dilatation OD, VD + surcharge pulm.
→ HTAP modérée
- fuite mitrale → favorise la CIA

CAV partiel

- **Diagnostic:**

- SF:

- discrets → diagnostic tardif (vers 1 – 2 ans)
 - bronchites à répétition
 - dyspnée d'effort

- SP:

- auscultation: (CIA + IM)
 - souffle syst. 2/6 au foyer pulm
 - BB2 permanent, espacé
 - souffle syst. apexien

CAV partiel

- **Radiographie:**
 - cardiomégalie modérée
 - hypervascularisation pulm.
 - arc moyen convexe
- **ECG:**
 - axe QRS « au plafond »
 - Bloc incomplet droit en V1
 - HAD
 - BAV 1

CAV partiel

- **Echodoppler:**
 - confirme le diagnostic
 - montre la CIA ostium primum
 - évalue l'insuffisance mitrale
 - évalue l'HTAP

CAV partiel

- **Evolution:**
 - CIA avec évolution plus rapide (shunt auriculaire favorisé par la fuite mitrale)
 - HTAP croissante, fixée vers l'âge adulte
 - IC
 - troubles du rythme auriculaire
 - Osler toujours possible

CONCLUSION

- CAV = principale cardiopathie des **trisomies 21**
- CAV = CIA + CIV + anomalie mitrale
- Signes cliniques et évolution spontanée = fonction de l'importance respective de CIA et CIV
- **Axe QRS au plafond** = forte présomption diagnostique